

NS 22231568273 575

CAIO AUGUSTO TADEU CARVALHO DE ALMEIDA

IDADE: 39

PESO: 87

ALTURA: 178

PROFISSÃO: Advogado.

SINTOMAS: Cansaço

QUEIXAS: Ronco - seguido apnéia. / Dependência Rivotril (10ans.)

MEDICAMENTOS: Donarem - monax.

↑ glicemia / ↑ colesterol (controle alimentar).

MÉDICO: Dr. Alberto

EXERCÍCIO FÍSICO: natação (3x)

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 21

HORA QUE DORME: 23:30

HORA QUE ACORDA: 7hr.

COCHILO () SIM (X) NÃO

DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: -

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1 a 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI:

IAH: 23,3 e/lv SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

Obstrução nasal
Desvio septo.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (X) ENDÓCRINA (N) CARDIACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Rinite/

10/07 Retorno

P = 6.6 cmH₂O

Fix. atitudinalmente on line - fus.

07

08 P = 6.6 cmH₂O

23 IAH = 2.1 e/lv

m. de uso: 3h45'

Adaptar o uso, constante, relata cefaleia - fus.

14/09 P = 6.6 cmH₂Oestava utilizando
em dias alternadas
fus

23 IAH = 1.2 e/lv

m. de uso: 3h50'

Fuga = 10.8 e/min.

28/11 P = 6.6 cmH₂O

23 IAH = 0.9 e/lv

m. de uso: 4hr.

22/05

Paciente retomando a utilizar a aparelha
Realiza ajuste de máscara
e orientações de uso

24

P = 6.6

Natação

20/06

P = 6.6 cmH₂OOriento sobre a
traqueia. fus

24

IAH = 1.1
m. de uso: 4hr.



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificação em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
CRM-SP: 69.730

DRa. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Crianças e Adolescentes
CRM-SP: 62.858

Caio Augusto Tadeu Carvalho de Almeida

Solicito o aluguel ou compra
do CPAP para o tratamento da síndrome
da apnéia do sono.

Ele usou a máscara nasal Adeva
large (Resmed).

A pressão recomendada: 6,5 cmH₂O.

Att,

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP: 69.730

STC, 26/6/23

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Caio Augusto Tadeu Carvalho de Almeida
EXAME n°: 5319-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 15/05/2023
IDADE: 39 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h48min e concluído às 06h41min. A latência para o sono foi de 3 minutos e a latência para o estágio REM, de 117 minutos. O tempo total de sono foi de 393 minutos (06h33min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 95,9%. A distribuição do sono mostrou 4,3% de estágio 1, 45,7% de estágio 2, 18,3% de estágio 3 e 31,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 13,5 minutos em vigília, ocorreram 42 microdespertares (índice: 6,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 8,1/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 2,9/hora, sendo 0 apneia/hora e 2,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 2,9/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 85%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Activa large (Resmed®). A pressão final recomendada foi de 6,5 cm H₂O.

Os índices de apneia/hipopneia (2,9/hora; índice normal até 4/hora) e de distúrbio respiratório (2,9/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 54; máxima: 69 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 3 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (117 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (95,9%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (6,4/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (18,3%; normal: 15-16%) e REM (31,7%; normal: 20%), e a redução do estágio 1 (4,3%; normal: 5%). A porcentagem do estágio 2 (45,7%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (8,1/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Caio Augusto Tadeu Carvalho de Almeida
EXAME nº: 5319
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar López
DATA: 24/02/2023
IDADE: 39 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h22min e concluído às 06h22min. A latência para o sono foi de 16 minutos e a latência para o estágio REM, de 150 minutos. O tempo total de sono foi de 439,5 minutos (07h19min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 92%. A distribuição do sono mostrou 14,8% de estágio 1, 62% de estágio 2, 4,7% de estágio 3 e 18,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 21,5 minutos em vigília, ocorreram 103 microdespertares (índice: 14,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 7,5/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 23,3/hora, sendo 3,4 apneia/hora e 19,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 28,8/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 82%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos moderados dos índices de apneia/hipopneia (23,3/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (28,8/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 54; máxima: 74 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 16 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (150 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (92%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (14,1/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (14,8%; normal: 5%) e 2 (62%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (4,7%; normal: 15-16%) e REM (18,5%; normal: 20%).

O índice de movimentos periódicos de membros (7,5/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Escala de Sonolência de Epworth: 9 (normal até 9; máxima: 24).